ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΠΟΝΟΥΣ

Ενημέρωση Κρίσιμου Ευρήματος: Πώς το Λέτε στο Τηλέφωνο

Είδατε το κρίσιμο εύρημα· τώρα πρέπει να το πείτε στο τηλέφωνο σε 30 δευτερόλεπτα, πλήρως και χωρίς παρεξηγήσεις. Η δομή Κατάσταση · Ιστορικό · Εκτίμηση · Σύσταση, 12 έτοιμες συνομιλίες και τι καταγράφεται στη γνωμάτευση.

Περιεχόμενα

Τι είναι κρίσιμο εύρημα και γιατί τηλέφωνο;

Συνομιλία σε τέσσερα βήματα: Κατάσταση · Ιστορικό · Εκτίμηση · Σύσταση

Πριν και μετά τη συνομιλία

12 έτοιμα παραδείγματα συνομιλίας

Τι καταγράφεται στη γνωμάτευση

Δύσκολες καταστάσεις

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Τι είναι κρίσιμο εύρημα και γιατί τηλέφωνο;

Ο τελευταίος κρίκος του βήματος ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ: ενημερώστε για το επείγον εύρημα.

> *Η δουλειά δεν τελειώνει όταν η γνωμάτευση μπει στο σύστημα, αλλά όταν ο σωστός ιατρός μάθει το εύρημα.*

Κρίσιμο εύρημα είναι αυτό που, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς ή κάποιο όργανο. Ποια ευρήματα αναφέρονται τηλεφωνικά το αποφασίζει η λίστα του ιδρύματός σας· τα παρακάτω είναι παραδείγματα που εμφανίζονται συχνά σε αυτές τις λίστες.

Νευροακτινολογία και σπονδυλική στήλη

Ενδοκράνια αιμορραγία · πιεστική επίδραση και εγκεφαλικός εγκολεασμός · ευρήματα οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου · οξύς υδροκέφαλος · πίεση νωτιαίου μυελού · ασταθές κάταγμα σπονδυλικής στήλης

Θώρακας

Πνευμοθώρακας με σημεία τάσης · πνευμονική εμβολή · διαχωρισμός αορτής · σωλήνας ή καθετήρας σε λάθος θέση · υποψία επιπωματισμού

Κοιλία και πύελος

Ελεύθερος αέρας · απόφραξη με σημεία ισχαιμίας · ΑΑΑ με σημεία ρήξης · ενεργός αιμορραγία · έκτοπη κύηση · συστροφή όρχεος ή ωοθήκης

Παιδιά και λοιπά

Εγκολεασμός εντέρου · ξένο σώμα ή μπαταρία κομβίου στον οισοφάγο · κάθε απρόσμενο εύρημα που θα αλλάξει την κλινική απόφαση

Ο κανόνας σας ως ειδικευόμενου

Αν δεν είστε βέβαιοι αν ένα εύρημα είναι κρίσιμο, ενημερώστε και συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας. Η διαδικασία ενημέρωσης του τμήματός σας προηγείται αυτού του υλικού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Συνομιλία σε τέσσερα βήματα

Η ελληνική απόδοση της δομής SBAR: Κατάσταση · Ιστορικό · Εκτίμηση · Σύσταση.

ΒΗΜΑ	ΤΙ ΛΕΤΕ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΡΑΣΗΣ
Κ · Κατάσταση	Ποιος είστε, ποιος ασθενής, το σημαντικότερο εύρημα — σε μία πρόταση.	«Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. Για τον/την [όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]: στην [εξέταση] υπάρχει [εύρημα].»
Ι · Ιστορικό	Γιατί και πότε έγινε η εξέταση· το ερώτημα του παραπεμπτικού.	«Έγινε λόγω [κλινική κατάσταση] στις [ώρα]· ερώτημα παραπεμπτικού «[ερώτημα]».»
Ε · Εκτίμηση	Η βαρύτητα του ευρήματος: μέγεθος, πιεστική επίδραση, μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.	«[Μέτρηση/βαθμός]· στην προηγούμενη εξέταση [δεν υπήρχε/υπήρχε].»
Σ · Σύσταση	Τι περιμένετε και αίτημα για επανάληψη (read-back).	«Προτείνω [επείγουσα εκτίμηση / συμπληρωματική εξέταση]. Μπορείτε να το επαναλάβετε;»

Ταυτότητα ασθενούς: δύο αναγνωριστικά

Στην αρχή της συνομιλίας αναφέρετε τον ασθενή με τουλάχιστον δύο αναγνωριστικά (ονοματεπώνυμο και αριθμό πρωτοκόλλου ή ημερομηνία γέννησης). Οι ασθενείς με παρόμοια ονόματα είναι η συχνότερη αιτία σύγχυσης.

Επανάληψη (read-back)

Ζητήστε από τον συνομιλητή να επαναλάβει το εύρημα και τον ασθενή. Η επανάληψη είναι ο απλούστερος τρόπος να εντοπιστεί στο τηλέφωνο σύγχυση πλευράς και ασθενούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Πριν και μετά τη συνομιλία

30 δευτερόλεπτα προετοιμασία πριν σηκώσετε το τηλέφωνο, ένα λεπτό καταγραφή αφού το κλείσετε.

Πριν τηλεφωνήσετε

- [ ] Η ταυτότητα του ασθενούς και η εξέταση είναι ανοιχτές στην οθόνη σας.
- [ ] Εντοπίστηκε ο ιατρός που έγραψε το παραπεμπτικό ή ο ιατρός που είναι εκείνη τη στιγμή υπεύθυνος για τον ασθενή.
- [ ] Το εύρημα, η πλευρά και η μέτρηση γράφτηκαν σε χαρτί ή στο προσχέδιο της γνωμάτευσης.
- [ ] Ελέγχθηκε η προηγούμενη εξέταση (νέο ή γνωστό εύρημα;).
- [ ] Εφόσον χρειάζεται, ενημερώθηκε ο επιμελητής σας.

Μετά το κλείσιμο

- [ ] Η ενημέρωση καταγράφηκε στη γνωμάτευση: ώρα, σε ποιον (ιδιότητα, τμήμα), με ποιον τρόπο.
- [ ] Καταγράφηκε ότι έγινε επανάληψη (read-back).
- [ ] Αν το ίδρυμά σας έχει σύστημα καταγραφής κρίσιμων ευρημάτων, καταχωρίστηκε και εκεί.
- [ ] Η γνωμάτευση καταχωρίστηκε στο σύστημα χωρίς καθυστέρηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

12 έτοιμα παραδείγματα συνομιλίας

Συμπληρώστε τις αγκύλες· προσαρμόστε τις προτάσεις στον δικό σας τρόπο ομιλίας, διατηρώντας τη σειρά.

01 Ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση

Ακτινογραφία θώρακα στην κλίνη, μονάδα εντατικής θεραπείας.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας **[το όνομά σας]**. **[Κλίνη/τμήμα]** — ο ασθενής σας **[όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]** — **[ώρα]**, ακτινογραφία θώρακα: βλέπω **[δεξιά]** μεγάλο πνευμοθώρακα και παρεκτόπιση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ασθενής **[διασωληνωμένος/μετά από επέμβαση]**· ερώτημα παραπεμπτικού «**[ερώτημα του παραπεμπτικού]**».
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Τα ευρήματα είναι υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση. Στην προηγούμενη ακτινογραφία ο πνευμοθώρακας **[δεν υπήρχε]**.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω να εκτιμήσετε αμέσως τον ασθενή. Μπορείτε να μου επαναλάβετε το εύρημα;

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «**[Δεξιά]** μεγάλος πνευμοθώρακας και ακτινολογικά ευρήματα υπέρ τάσης. **[Ώρα]**: **[ιδιότητα, τμήμα]** — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός και η πληροφορία επιβεβαιώθηκε με επανάληψη.»

02 Οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ΤΕΠ, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας **[το όνομά σας]**. Ασθενής στα ΤΕΠ: **[όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]** — στην αξονική εγκεφάλου: **[δεξιά κροταφικά]** υπάρχει οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Έγινε μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση· ερώτημα παραπεμπτικού «αιμορραγία;».
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Μέγιστο πάχος **[.. mm]**, μετατόπιση της μέσης γραμμής **[.. mm]**· υπερκείμενα: **[γραμμοειδές κάταγμα]**.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Μπορεί να χρειαστεί επείγουσα νευροχειρουργική εκτίμηση· καταχωρίζω τώρα τη γνωμάτευση στο σύστημα.

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «**[Δεξιά κροταφικά]** οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα, **[.. mm]** μετατόπιση της μέσης γραμμής. **[Ώρα]**: ΤΕΠ, **[ιδιότητα]** — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός· έγινε επανάληψη (read-back).»

03 Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. [Όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου] — στην αξονική εγκεφάλου βλέπω υπαραχνοειδή αιμορραγία.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Έγινε λόγω αιφνίδιας κεφαλαλγίας· ιστορικό τραύματος [όχι].
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Αιμορραγία [στις βασικές δεξαμενές] διάχυτη· υδροκέφαλος [όχι/ναι].
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω αξονική αγγειογραφία για ανεύρυσμα· σας παρακαλώ να το εκτιμήσετε με το αρμόδιο τμήμα.

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «Υπαραχνοειδής αιμορραγία· προτείνεται αξονική αγγειογραφία. [Ώρα]: [ιδιότητα, τμήμα] — ενημερώθηκε ο ιατρός.»

04 Οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο · υπέρπυκνη MCA

Κωδικός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. Ασθενής σε πρωτόκολλο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου: [όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου] — στην αξονική δεν υπάρχει αιμορραγία· [αριστερά] στην MCA υπάρχει σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας και πρώιμα σημεία ισχαιμίας.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Η έναρξη των συμπτωμάτων αναγράφεται στο παραπεμπτικό: [ώρα] .
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Δεν παρατηρείται αιμορραγία· [αριστερά] στην αγγειακή περιοχή της MCA πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω εκτίμηση με αξονική αγγειογραφία. Μπορείτε να μου επαναλάβετε το εύρημα;

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «Χωρίς ενδοκράνια αιμορραγία· [αριστερά] στην MCA σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας και πρώιμα σημεία ισχαιμίας. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου [ώρα]: [ιδιότητα, τμήμα] — ενημερώθηκε ο ιατρός.»

05 Πνευμονική θρομβοεμβολή

Αξονική πνευμονική αγγειογραφία, νοσηλευόμενος ασθενής.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. [Τμήμα] — ο ασθενής σας [όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου] — στην αξονική πνευμονική αγγειογραφία υπάρχει αμφοτερόπλευρη πνευμονική εμβολή.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω δύσπνοιας και ταχυκαρδίας.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Εμβολές σε [λοβιακό και τμηματικό] επίπεδο· σημεία υπερφόρτωσης δεξιάς κοιλίας [ναι/όχι].
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω να εκτιμήσετε τον ασθενή· η γνωμάτευση είναι στο σύστημα.

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «Αμφοτερόπλευρη οξεία πνευμονική θρομβοεμβολή· σημεία υπερφόρτωσης δεξιάς κοιλίας [ναι/όχι]. [Ώρα]: [ιδιότητα, τμήμα] — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός.»

06 Διαχωρισμός αορτής

Πόνος στο στήθος και στη ράχη, αξονική αγγειογραφία.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας **[το όνομά σας]**. Ασθενής στα ΤΕΠ: **[όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]** — στην αξονική αγγειογραφία υπάρχει διαχωρισμός αορτής· η ανιούσα αορτή **[συμμετέχει/δεν συμμετέχει]**.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω αιφνίδιου πόνου στο στήθος και στη ράχη.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Ο διαχωρισμός **[από την ανιούσα αορτή]** ξεκινά και εκτείνεται έως **[επίπεδο]**· περικαρδιακή συλλογή **[όχι/ναι]**.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Μπορεί να χρειαστεί επείγουσα καρδιοχειρουργική-αγγειοχειρουργική εκτίμηση· μπορείτε να μου επαναλάβετε το εύρημα;

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «**[Stanford A]** διαχωρισμός αορτής. Επείγον εύρημα· **[ώρα]**: ΤΕΠ, **[ιδιότητα]** — ενημερώθηκε ο ιατρός και επιβεβαιώθηκε με επανάληψη.»

07 Πνευμοπεριτόναιο

Οξεία κοιλία, ακτινογραφία θώρακα σε όρθια θέση / αξονική τομογραφία κοιλίας.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας **[το όνομά σας]**. **[Όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]** — στην εξέταση βλέπω ελεύθερο αέρα κάτω από το διάφραγμα.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω κοιλιακού άλγους· πρόσφατο χειρουργικό ιστορικό στο παραπεμπτικό: **[δεν αναφέρεται]**.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Ελεύθερος αέρας **[αμφοτερόπλευρα]**· πιθανό σημείο διάτρησης στην αξονική: **[εντόπιση]**.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω επείγουσα χειρουργική εκτίμηση. Υπάρχει πρόσφατο ιστορικό χειρουργείου ή επέμβασης;

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «Πνευμοπεριτόναιο· υπέρ διάτρησης κοίλου σπλάχνου. **[Ώρα]**: **[ιδιότητα, τμήμα]** — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός.»

08 Ρινογαστρικός σωλήνας σε λάθος θέση

Ακτινογραφία στην κλίνη πριν από τη σίτιση.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας **[το όνομά σας]**. **[Κλίνη/τμήμα]** — ο ασθενής σας **[όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]** — στην ακτινογραφία ελέγχου του ρινογαστρικού σωλήνα, άκρο σωλήνα: **[δεξιός κύριος βρόγχος]** (προβολή).
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε έλεγχος της θέσης του σωλήνα πριν από την έναρξη της σίτισης.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Ο σωλήνας δεν βρίσκεται σε κατάλληλη θέση· **[χωρίς πνευμοθώρακα]**.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω να διορθωθεί η θέση του σωλήνα πριν χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να μου επαναλάβετε το εύρημα;

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «Άκρο ρινογαστρικού σωλήνα: **[δεξιός κύριος βρόγχος]** (προβολή), δεν βρίσκεται σε κατάλληλη θέση. Πριν από τη χρήση — **[ώρα]**: **[ιδιότητα, τμήμα]** — ενημερώθηκε ο ιατρός/η νοσηλεύτρια.»

09 Συστροφή όρχεος

Αιφνίδιος πόνος στο όσχεο, υπερηχογράφημα Doppler όσχεου.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. [Όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου] — στο Doppler όσχεου: [αριστερά] όρχις: δεν παρατηρείται αιματική ροή.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω αιφνίδιου πόνου στο όσχεο· έναρξη [ώρα].
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Τα ευρήματα είναι συμβατά με συστροφή· ο αντίθετος όρχις είναι φυσιολογικός.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω επείγουσα ουρολογική εκτίμηση.

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «[Αριστερά] όρχις: ευρήματα συμβατά με συστροφή. Επείγον εύρημα· [ώρα]: [ιδιότητα, τμήμα] — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός.»

10 Ευρήματα υπέρ έκτοπης κύησης

Θετικό τεστ κύησης, υπερηχογράφημα πυέλου.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. [Όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου] — στο υπερηχογράφημα πυέλου δεν βλέπω ενδομήτρια κύηση· [δεξιά] υπάρχει μάζα εξαρτημάτων και ελεύθερο υγρό.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω θετικού τεστ κύησης και πυελικού άλγους.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Τα ευρήματα είναι υπέρ έκτοπης κύησης· ελεύθερο υγρό [με ηχογενές περιεχόμενο].
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω επείγουσα γυναικολογική-μαιευτική εκτίμηση. Μπορείτε να μου επαναλάβετε το εύρημα;

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «Δεν παρατηρείται ενδομήτρια κύηση· [δεξιά] μάζα εξαρτημάτων και ελεύθερο υγρό, ευρήματα υπέρ έκτοπης κύησης. [Ώρα]: [ιδιότητα, τμήμα] — ενημερώθηκε ο ιατρός.»

11 Πίεση νωτιαίου μυελού

Γνωστή κακοήθεια, πόνος στη ράχη, μαγνητική θωρακικής μοίρας.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας [το όνομά σας]. [Όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου] — στη μαγνητική θωρακικής μοίρας: [Θ..] επίπεδο: υπάρχει πίεση του νωτιαίου μυελού.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω γνωστής κακοήθειας και νέου πόνου στη ράχη.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	Η πίεση μπορεί να είναι συμβατή με επισκληρίδια επέκταση όγκου· μεταβολή σήματος στον νωτιαίο μυελό [ναι/όχι].
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω επείγουσα εκτίμηση· απεικόνιση όλης της σπονδυλικής στήλης [έγινε/μπορεί να χρειαστεί].

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «[Θ..] επίπεδο: βλάβη πιθανώς συμβατή με επισκληρίδια επέκταση όγκου και πίεση του νωτιαίου μυελού. [Ώρα]: [ιδιότητα, τμήμα] — ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός.»

12 Εγκολεασμός εντέρου (παιδιά)

Διαλείπον κοιλιακό άλγος, υπερηχογράφημα κοιλίας.

Κ · ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ειδικευόμενος ακτινολογίας **[το όνομά σας]**. Ασθενής στα παιδιατρικά ΤΕΠ: **[όνομα ασθενούς, αρ. πρωτοκόλλου]** — στο υπερηχογράφημα κοιλίας βλέπω **[ειλεοκολικό]** εγκολεασμό.
Ι · ΙΣΤΟΡΙΚΟ	Ζητήθηκε λόγω διαλείποντος κοιλιακού άλγους και εμέτων.
Ε · ΕΚΤΙΜΗΣΗ	**[Στο δεξιό ήμισυ της κοιλίας]** εικόνα στόχου· αιματική ροή τοιχώματος **[διατηρημένη/μειωμένη]**, ελεύθερο υγρό **[όχι/ναι]**.
Σ · ΣΥΣΤΑΣΗ	Προτείνω επείγουσα εκτίμηση από παιδοχειρουργό.

Καταγραφή στη γνωμάτευση: «**[Ειλεοκολικός]** εγκολεασμός: συμβατά ευρήματα. Επείγον εύρημα· **[ώρα]**: **[ιδιότητα, τμήμα]** — ενημερώθηκε ο ιατρός.»

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Τι καταγράφεται στη γνωμάτευση

Η ενημέρωση που δεν καταγράφεται δεν μπορεί να επαληθευτεί αργότερα.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Τι αναφέρθηκε	Το κρίσιμο εύρημα στο Συμπέρασμα, με τις ίδιες λέξεις με τη γνωμάτευση.
Ώρα	«στις [ώρα]» — και ημερομηνία, αν δεν προκύπτει από την ίδια τη γνωμάτευση.
Σε ποιον	Ιδιότητα και τμήμα: «εφημερεύων ιατρός ΤΕΠ», «υπεύθυνος ιατρός [τμήματος]». Η αναγραφή ονόματος εξαρτάται από την πρακτική του ιδρύματός σας.
Με ποιον τρόπο	Τηλεφωνικά / δια ζώσης.
Επιβεβαίωση	«Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε με επανάληψη (read-back).»

Πρότυπο πρότασης καταγραφής

«[Εύρημα]. [Ώρα]: ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο ιατρός [ιδιότητα, τμήμα] και η πληροφορία επιβεβαιώθηκε με επανάληψη.»

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Δύσκολες καταστάσεις

Το τηλέφωνο δεν απαντιέται πάντα με την πρώτη κλήση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ
Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό που έγραψε το παραπεμπτικό	Επικοινωνήστε με τον ιατρό που είναι εκείνη τη στιγμή υπεύθυνος για τον ασθενή ή με τον εφημερεύοντα του τμήματος· ακολουθήστε τη σειρά κλιμάκωσης του ιδρύματός σας. Καταγράψτε τις προσπάθειες και τις ώρες τους· ενημερώστε τον επιμελητή σας.
Ο συνομιλητής γνωρίζει ήδη το εύρημα	Ενημερώστε ωστόσο σύντομα και καταγράψτε το ως «επιβεβαιώθηκε ως γνωστό εύρημα»· αναφέρετε ιδιαίτερα τη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.
Δεν είστε βέβαιοι για το εύρημα	Μην καθυστερείτε την ενημέρωση· συμβουλευτείτε αμέσως τον επιμελητή σας. Δηλώστε σαφώς το επίπεδο βεβαιότητας και στο τηλέφωνο: «υπέρ», «ύποπτο».
Η συνομιλία παρατείνεται ή μετατρέπεται σε αντιπαράθεση	Επιστρέψτε στα τέσσερα βήματα, επαναλάβετε τη σύσταση και εμπλέξτε τον επιμελητή σας. Η κλινική απόφαση ανήκει στην κλινική ομάδα· το δικό σας καθήκον είναι η σωστή και έγκαιρη μετάδοση του ευρήματος.
Προκαταρκτική γνωμάτευση στη νυχτερινή εφημερία	Το κρίσιμο εύρημα αναφέρεται και καταγράφεται με τον ίδιο τρόπο και στην προκαταρκτική γνωμάτευση· αν υπάρξει αλλαγή μετά την οριστική γνωμάτευση, γίνεται νέα ενημέρωση.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τώρα επιστρέψτε στο Κύριο υλικό · 120 Έτοιμα Πρότυπα Γνωμάτευσης. Συμπληρώστε τις προτάσεις ενημέρωσης στο πεδίο Συμπέρασμα των προτύπων επειγόντων ευρημάτων με το πρότυπο καταγραφής αυτής της ενότητας.

Για όλες τις προτάσεις συμπεράσματος επειγόντων ευρημάτων, ανατρέξτε στο **Μπόνους 1 · Τράπεζα 200 Συμπερασμάτων Γνωμάτευσης**: προτάσεις με την ετικέτα «Επείγον».